Codebook – rl_data

Variable in rl_data	Variablenbezeichnung	Frage im Survey	Skalierung	Kategorien & Wertelabels im Survey	Values in rl_data
1. Austausch zwischen ambulantem und stationärem Sektor					
DATUM	/	/	/	/	/
case	Anonyme Zählernummer	/	/		/
BER_score	Bereitschaft zur Umsetzung von eliPfad	BER1_BP, BER2_FM, BER3_SD, BER4_GK	Metrisch	/	Mittelwert aus BER1_BP, BER2_FM, BER3_SD, BER4_GK
MODUS	Rekrutierungsstrategie	/	Nominal	/	1 = E-Mail 2 = QR Code: postalisch mit Logo 3 = QR Code: postalisch ohne Logo 4 = Fragebogen mit Logo 5 = Fragebogen ohne Logo
Befragungsmodus	Befragungsmodus	/	Nominal	/	1 = online 2 = schriftlich
Versandmodus	Versandmodus	/	Nominal	/	1 = E-Mail 2 = Postalisch: QR-Code 3 = Postalisch: Fragebogen
EM_QUAL	Qualität Entlassmanagement	Wenn Sie an die Entlassungen Ihrer älteren multimorbiden Patient:innen denken, wie oft müsste das Entlassmanagement besser laufen?	Ordinal	1 = Sehr selten 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Sehr häufig	1 = Sehr selten 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Sehr häufig
ANZKH	Krankenhäuser Zusammenarbeit	Wie viele verschiedene Krankenhäuser behandeln in der Regel Ihre älteren multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen?	Metrisch	Anzahl	*Anzahl*
ANZENTL	Entlassene Patient:innen	Wie viele Ihrer älteren, multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen werden durchschnittlich pro Monat aus diesem Krankenhaus nach Hause entlassen? *Bitte schätzen Sie die Anzahl*	Metrisch	Anzahl	*Anzahl*
AUSGES	Kollegialer Austausch	Bei wieviel Prozent dieser Patient:innen findet ein direkter kollegialer Austausch zwischen Ihnen und den Klinikärzt:innen (z.B. über Telefon) statt?	Metrisch	Zahl %	*Zahl*
AUSINIT	Initiation Austausch	Wieviel Prozent dieses Austausches wird durch die Klinikärzt:innen initiiert?	Metrisch	Zahl %	*Zahl*

AUSKW_1 AUSKW_2 AUSKW_3 AUSKW_4 AUSKW_5 AUSKW_6 AUSKW_7 AUSKW_8 AUSKW_T	- Austausch Telefonat (1) - Austausch E-Mail (2) - Austausch Messenger (3) - Austausch KIM (4) - Austausch Videokonferenz (5) - Austausch Persönlich (6) - Austausch Fax (7) - Austausch Sonstiger (8) - Sonstiger Austausch (T = *FREITEXT für „Sonstiger“*)	Welche/n direkten Kommunikationsweg/e bevorzugen Sie für diesen Austausch mit Klinikärzt:innen? *Mehrfachauswahl möglich*	Nominal	1 = Telefonat 2 = E-Mail 3 = Messenger Dienst 4 = KIM 5 = Videokonferenz 6 = Persönliches Treffen 7 = Fax 8 = Sonstiger	1 = gewählt 0 = nicht gewählt *AUSKW_T = Text*
AUSERR	Erreichbarkeit außerhalb	Sind Sie außerhalb Ihrer regulären Arbeitszeit für die Klinikärzt:innen erreichbar?	Nominal	1 = Ja 0 = Nein	1 = Ja 0 = Nein
AUSGEL	Austausch Gelegenheiten	Bitte bewerten Sie die aktuellen Gelegenheiten für den Austausch zwischen Ihnen und den Klinikärzt:innen des besagten Krankenhauses.	Ordinal	1 = Es gibt keine Gelegenheiten für den Austausch 2 = Es gibt wenige Gelegenheiten für den Austausch 3 = Es gibt einige Gelegenheiten für den Austausch 4 = Es gibt viele Gelegenheiten für den Austausch	1 = Es gibt keine Gelegenheiten für den Austausch 2 = Es gibt wenige Gelegenheiten für den Austausch 3 = Es gibt einige Gelegenheiten für den Austausch 4 = Es gibt viele Gelegenheiten für den Austausch
AUSGEL2	Austausch Verantstaltungen	Falls es gemeinsame Veranstaltungen für den Austausch gibt, nehmen Sie an diesen Teil?	Nominal	1 = Ja 0 = Nein 2 = Es gibt keine gemeinsamen Veranstaltungen	1 = Ja 0 = Nein 2 = Es gibt keine gemeinsamen Veranstaltungen

2. Versorgungskoordination an der ambulant-stationären Schnittstelle					
RC1_COM	RC Häufigkeit Kommunikation	Wie häufig kommunizieren Klinikärzt:innen mit Ihnen über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Nicht annähernd genug 3 = Nicht genug 5 = Genau im richtigen Maß 4 = Zu oft 2 = Viel zu oft	1 = Nicht annähernd genug 3 = Nicht genug 5 = Genau im richtigen Maß 4 = Zu oft 2 = Viel zu oft
RC2_COM	RC Zeitpunkt Kommunikation	Kommunizieren die Klinikärzt:innen mit Ihnen zum richtigen Zeitpunkt über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Nie 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Immer	1 = Nie 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Immer
RC3_COM	RC Präzision Kommunikation	Kommunizieren die Klinikärzt:innen inhaltlich präzise mit Ihnen über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Nie 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Immer	1 = Nie 2 = Selten 3 = Manchmal 4 = Häufig 5 = Immer
RC4_COM	RC Problemlösung Kommunikation	Wenn es ein Problem mit der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen gibt, machen die Klinikärzt:innen andere für die Lösung verantwortlich oder arbeiten sie mit Ihnen zusammen, um das Problem zu lösen?	Ordinal	1 = Machen immer andere verantwortlich 2 = Machen meistens andere verantwortlich 3 = Weder noch 4 = Lösen das Problem meistens zusammen 5 = Lösen das Problem immer zusammen	1 = Machen immer andere verantwortlich 2 = Machen meistens andere verantwortlich 3 = Weder noch 4 = Lösen das Problem meistens zusammen 5 = Lösen das Problem immer zusammen
RC5_REL	RC Ziele teilen	Teilen Klinikärzt:innen Ihre Ziele bezogen auf die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Überhaupt nicht 2 = Ein wenig 3 = Teilweise 4 = Größtenteils 5 = Voll und ganz	1 = Überhaupt nicht 2 = Ein wenig 3 = Teilweise 4 = Größtenteils 5 = Voll und ganz
RC6_REL	RC Wissen Klinikärzt:innen	Wie viel wissen Klinikärzt:innen über Ihre Arbeit bei der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Nichts 2 = Wenig 3 = Etwas 4 = Viel 5 = Alles	1 = Nichts 2 = Wenig 3 = Etwas 4 = Viel 5 = Alles
RC7_REL	RC Respekt	Respektieren Klinikärzt:innen Ihre Arbeit bei der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Ordinal	1 = Überhaupt nicht 2 = Ein wenig 3 = Teilweise 4 = Größtenteils 5 = Voll und ganz	1 = Überhaupt nicht 2 = Ein wenig 3 = Teilweise 4 = Größtenteils 5 = Voll und ganz
RC_score	"Relational Coordination Score"	RC1_COM bis RC7_REL	Metrisch	/	Mittelwert aus allen RC Variablen

RC_cat	„Relational Coordination Kategorien“	Basierend auf RC_score < 3,5 → 1 >= 3,5 <=4 → 2 > 4 → 3	Ordinal	/	1 = Schwach 2 = Moderat 3 = Stark
RC_di	„Relational Coordination dichotomisiert“	Basierend auf RC_score < 3,5 → 1 >= 3,5 → 2	Kategorial	/	1 = Schwach 2 = Moderat/stark
RC_com	"Relational Coordination Subscore Kommunikation"	RC1_COM bis RC4_COM	Metrisch	/	Mittelwert aus allen RC_COM Variablen
RC_rel	"Relational Coordination Subscore Beziehung"	RC5_REL bis RC7_REL	Metrisch	/	Mittelwert aus allen RC_REL Variablen
3. Ihr Verhältnis zu den Klinikärzt:innen der besagten Klinikabteilung(en)					
VERKLI_1	Verhältnis Klinikärzt:innen	Die Klinikärzt:innen halten sich für etwas Besseres	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
VERKLI_2	Verhältnis KÄ Arroganz	Die Klinikärzt:innen verhalten sich mir gegenüber arrogant	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
VERKLI_3	Verhältnis KÄ Information	Die Klinikärzt:innen informieren nur auf Anfrage	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
VERKLI_4	Verhältnis KÄ vergessen	Die Klinikärzt:innen vergessen schon einmal ein Anliegen, was man hat	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
VERKLI_5	Verhältnis KÄ Zeit	Die Klinikärzt:innen haben zu wenig Zeit für mich	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
VERKLI_roh	Verhältnis zu Klinikärzt:innen Rohskala	VERKLI_1 bis VERKLI_5	Metrisch	/	Summe aus VERKLI_1 bis VERKLI_5
VERKLI_score	Verhältnis zu Klinikärzt:innen Score	VERKLI_1 bis VERKLI_5	Metrisch	/	Mittelwert aus VERKLI_1 bis VERKLI_5

4. Informationsübermittlung und Absprachen beim Entlassmanagement					
Wie häufig treten die folgenden Szenarien im Entlassprozess des besagten Krankenhauses auf? *In wie viel Prozent der Fälle kommt es vor, dass…*					
INFO_BP	Info Behandlungsplanung	Sie vor der Entlassung für die Behandlungsplanung Ihrer Patient:innen kontaktiert werden?	Ordinal/Metrisch	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Weiß nicht = 999	0 = 0% 10 = 10% 20 = 20% 30 = 30% 40 = 40% 50 = 50% 60 = 60% 70 = 70% 80 = 80% 90 = 90% 100 = 100% 999 = Weiß nicht
INFO_HLP	Info Hilfe	die Einleitung pflegerischer oder sozialer Hilfe mit Ihnen abgestimmt wird?			
INFO_EB1	Info Entlassbrief	Sie im Entlassbrief unvollständige Informationen erhalten, die eine kontinuierliche Weiterversorgung beeinträchtigen?			
INFO_EB2	Info Entlassbrief Rückfragen	Sie als Ärzt:in sich mit Rückfragen zum Entlassbrief an eine/einen der Klinikärzt:innen wenden?			
INFO_AP1	Info Ansprechperson	Sie keine Rufnummer einer zuständigen ärztlichen Ansprechperson für Rückfragen haben?			
INFO_AP2	Info Ansprechperson Erreichbarkeit	Sie eine Ansprechperson nach Entlassung erreichen wollen und es Ihnen nicht gelingt?			
INFO_MD1	Info Medikation	Sie die Medikation aus der Klinik unverändert übernehmen können?			
INFO_MD2	Info Medikation nachvollziehbar	Sie die aus der Klinik verordneten Medikamente nicht inhaltlich nachvollziehen können?			
Wie oft würden Sie sich wünschen…					
WUN_BP	Wunsch Kontakt	bezüglich der Behandlungsplanung Ihrer Patient:innen vor der Entlassung kontaktiert zu werden?	Nominal	1 = Deutlich häufiger als aktuell 2 = Etwas häufiger als aktuell 3 = Gleich häufig wie aktuell 4 = Etwas seltener als aktuell 5 = Deutlich seltener als aktuell 6 = Wünsche ich mir nicht	1 = Deutlich häufiger als aktuell 2 = Deutlich seltener als aktuell 3 = Etwas häufiger als aktuell 4 = Etwas seltener als aktuell 5= Gleich häufig wie aktuell 6 = Wünsche ich mir nicht
WUN_SOZ	Wunsch Abstimmung	dass die Einleitung pflegerischer oder sozialer Hilfe mit Ihnen abgestimmt wird?	Nominal	1 = Deutlich häufiger als aktuell 2 = Etwas häufiger als aktuell 3 = Gleich häufig wie aktuell 4 = Etwas seltener als aktuell 5 = Deutlich seltener als aktuell 6 = Wünsche ich mir nicht	1 = Deutlich häufiger als aktuell 2 = Deutlich seltener als aktuell 3 = Etwas häufiger als aktuell 4 = Etwas seltener als aktuell 5= Gleich häufig wie aktuell 6 = Wünsche ich mir nicht

5. Sektorenübergreifende Behandlungs- und Medikationsplanung					
BER1_BP	Zustimmung Behandlungs- und Medikationsplanung	Ich wäre bereit, an der Behandlungs- und Medikationsplanung teilzunehmen.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
BPMEET BPMEET_T	- Durchführung Behandlungsplanung - Sonstige Behandlungsplanung (T = *FREITEXT für „Anders:“*)	Wie sollte die gemeinsame Behandlungs- und Medikationsplanung am besten durchgeführt werden?	Nominal	1 = als Videokonferenz 2 = als Telefonkonferenz 3 = als persönliches Treffen 4 = Anders, und zwar:	1 = als Videokonferenz 2 = als Telefonkonferenz 3 = als persönliches Treffen 4 = Anders *BPMEET_T = Text*
BPDAUER	effektive Besprechungsdauer	Wie lange denken Sie dauert eine effektive Besprechung je Patient:in durchschnittlich?	Metrisch	Zahl Minuten	*Zahl*
BPEURO	Vergütung Besprechung	Wie hoch müsste diese Besprechung zur Behandlungs- und Medikationsplanung zusätzlich vergütet werden?	Metrisch	Zahl Euro	*Zahl*
BP_MED	Mehrwert Medikation	Eine gemeinsam zwischen Ihnen und dem Behandlungsteam aus der Klinik interdisziplinär abgestimmte Medikation bietet einen Mehrwert für die Patient:innen (z.B. Sicherstellung der kontinuierlichen Versorgung, Einbeziehen von Erkenntnissen aus dem Klinikaufenthalt).	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Neutral 4 = Stimme eher zu 5 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Neutral 4 = Stimme eher zu 5 = Stimme voll und ganz zu
6.1 Fallmanager:innen für die Patientenbetreuung und Schnittstellenkoordination					
BER2_FM	Zustimmung Fallmanager:innen	Ich wäre bereit, mich mit den Fallmanager:innen abzustimmen.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
FMHB	Zeitpunkt Hausbesuch FM	Wann sollte der erste Hausbesuch durch die Fallmanager:innen spätestens erfolgen, um Ihnen die Arbeit in der Nachsorge zu erleichtern?	Metrisch	Zahl Tage	*Zahl*
FMEIN_1	Einschätzung FM	Fallmanager:innen kennen die Krankheitshistorie der Patient:innen nicht gut genug, um deren Gesundheitszustand auf Handlungsbedarf hin einschätzen zu können.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
FMEIN_2	Empfehlungen FM	Ich befürchte, dass den Patient:innen medizinisch unnötige Hilfen oder Behandlungen durch die Fallmanager:innen empfohlen werden.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu

FMEIN_3	Unterstützung Medikation	Eine Unterstützung der Patient:innen bei der Beschaffung, Lagerung und Anwendung von Arzneimitteln wäre eine sinnvolle Ergänzung im ambulanten Medikationsprozess.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
FM_INIT	Initiation Unterstützung	Wie wichtig ist es Ihnen als Hausärzt:in, die Unterstützung von Fallmanager:innen für einzelne Patient:innen zu initiieren oder beenden zu können?	Ordinal	5 = Sehr wichtig 4 = Wichtig 3 = Neutral 2 = Weniger wichtig 1 = Gar nicht wichtig 6 = keine Angabe	5 = Sehr wichtig 4 = Wichtig 3 = Neutral 2 = Weniger wichtig 1 = Gar nicht wichtig 999 = keine Angabe
FMAUFG_1 FMAUFG_2 FMAUFG_3 FMAUFG_4 FMAUFG_5 FMAUFG_6 FMAUFG_7 FMAUFG_8 FMAUFG_9 FMAUFG_10 FMAUFG_T	- Aufgabe Entlassung Koordination (1) - Aufgabe Beratung (2) - Aufgabe Dienste Koordination (3) - Aufgabe Rehaplanung (4) - Aufgabe Vitalwerte (5) - Aufgabe Risikofaktoren (6) - Aufgabe Medikation (7) - Aufgabe Bedarfe (8) - Aufgabe Adhärenzförderung (9) - Aufgabe Sonstige (10) - Sonstige Aufgaben FM (T = *FREITEXT für „Sonstige“*)	Welche Aufgaben könnten die Fallmanager:innen übernehmen, um die nachstationäre Versorgung Ihrer Patient:innen zu unterstützen?	Nominal	1 = Koordination der Entlassung gemeinsam mit den Patient:innen und dem Behandlungsteam 2 = Beratung und Schulung von Patient:innen und Angehörigen zu Selbstpflege und Krankheitsmanagement 3 = Koordination von Unterstützungsdiensten und sozialen Dienstleistungen 4 = Planung und Organisation von ambulanten Therapien oder Rehabilitationsmaßnahmen 5 = Überwachung von Vitalparametern und Rückmeldung an das Behandlungsteam 6 = Identifikation von Risikofaktoren und frühzeitiges Eingreifen bei Verschlechterung des Gesundheitszustands 7 = Regelmäßige Überprüfung des Medikamentenplanes 8 = Überprüfung, ob die häusliche Situation den Bedarfen der Patient:innen entspricht 9 = Förderung der Einhaltung von Therapieplänen und medizinischen Empfehlungen 10 = Etwas anderes, und zwar:	1 = gewählt 0 = nicht gewählt *FMAUFG_T = Text* *#CAVE: Im Papierfragebogen haben einige mehr als 3 Aufgaben ausgewählt – Ist auch so in rl_data. Vor Analysen müssen alle Personen, die mehr als 3 Aufgaben gewählt haben, ausgeschlossen werden.*

FMEFFEKT	Unterstützung FM hilfreich	Wenn Sie an Ihre älteren, multimorbiden Patient:innen denken, in wie viel Prozent der Fälle wäre die Unterstützung durch Fallmanger:innen hilfreich? *Bitte schätzen Sie*	Metrisch	Zahl %	*Zahl*
6.2 Telemedizinische Betreuung durch Smart Devices					
BER3_SD	Zustimmung Smart Devices	Ich wäre bereit, für diese Patient:innen die telemedizinische Betreuung zu übernehmen.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
SDEFFEKT	Nutzen SD	Wenn Sie an Ihre älteren, multimorbiden Patient:innen denken, in wie viel Prozent der Fälle fänden Sie die telemedizinische Betreuung hilfreich?	Metrisch	Zahl %	*Zahl*
SDFREQ SDFREQ_T	- Frequenz Monitoring - Sonstige Frequenz (T = *FREITEXT für „Andere Frequenz“)*	Wenn Sie die Wahl hätten, in welcher Frequenz sollte das Monitoring der Vitalparameter von den Fallmanger:innen durchgeführt werden, um rechtzeitig auf Abweichungen reagieren zu können?	Nominal	1 = Mehrmals täglich 2 = Täglich 3 = Jeden 2. Tag 4 = Mehrmals pro Woche 5 = Wöchentlich 6 = Andere Frequenz:	1 = Mehrmals täglich 2 = Täglich 3 = Jeden 2. Tag 4 = Mehrmals pro Woche 5 = Wöchentlich 6 = Andere Frequenz *SDFREQ_T = Text*
SDMPRAX	Monitoring ohne FM	Würden Sie das Monitoring der Vitalparameter in Ihrer Praxis auch ohne die Fallmanager:innen übernehmen?	Nominal	1 = Ja 2 = Vielleicht 0 = Nein	1 = Ja 2 = Vielleicht 0 = Nein

SDSTAT_1 SDSTAT_2 SDSTAT_3 SDSTAT_4 SDSTAT_5 SDSTAT_6 SDSTAT_7 SDSTAT_T	- Statusbericht E-Mail (1) - Statusbericht Brief (2) - Statusbericht Fax (3) - Statusbericht KIM (4) - Statusbericht Online (5) - Statusbericht Praxissoftware (6) - Statusbericht Sonstiges (7) - Sonstiger Statusbericht (T = *FREITEXT für „Etwas anderes, und zwar:“*)	Auf welchem Weg würden Sie den wöchentlichen Statusbericht am liebsten erhalten? *Mehrfachauswahl möglich*	Nominal	1 = E-Mail 2 = Brief 3 = Fax 4 = KIM 5 = Ansicht in einer Online-Plattform 6 = Ansicht in meiner Praxisverwaltungssoftware 7 = Etwas anderes, und zwar:	1 = gewählt 0 = nicht gewählt *SDSTAT_T = Text*
SDKONFM SDKONFM_T	- Kontaktaufnahme FM - Sonstige Kontakt FM (T = *FREITEXT für „Etwas anderes, und zwar:“)*	Auf welchem Weg sollten Fallmanager:innen Sie bei medizinischen Auffälligkeiten Ihrer Patient:innen kontaktieren?	Nominal	1 = E-Mail 2 = Fax 3 = KIM 4 = Praxistelefon 5 = Diensthandy 6 = Privathandy 7 = Etwas anderes, und zwar:	1 = E-Mail 2 = Fax 3 = KIM 4 = Praxistelefon 5 = Diensthandy 6 = Privathandy 7 = Etwas anderes *SDKONFM_T = Text*
Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu den Smart Devices zu?					
SD_AAUFW	Arbeitsaufwand SD	Ich habe Sorge vor einem erhöhten Arbeitsaufwand durch Rückfragen von Patient:innen zu den Smart Devices.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
SD_GRENZ	SD Überwachung	Ich würde das Monitoring der Vitalparameter nicht durchführen, da dies eine grenzüberschreitende Überwachung von Patient:innen darstellt.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu
7. Das Versorgungskonzept als Ganzes					
BER4_GK	Zustimmung Gesamtkonzept	Ich wäre bereit, das Konzept mit allen Bausteinen in meiner Versorgung zu erproben.	Ordinal	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu	1 = Stimme überhaupt nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme voll und ganz zu

GKINI_1 GKINI_2 GKINI_3 GKINI_4 GKINI_5 GKINI_T	- Initiation Klinikärzt:in (1) - Initiation Hausärzt:in (2) - Initiation Fallmanager:in (3) - Initiation Gemeinsam (4) - Initiation Weitere (5) - Sonstige Initiation (T = *FREITEXT für „Weitere:“*))	Wer sollte berechtigt sein, das Versorgungskonzept für die Patient:innen zu initiieren? Mehrfachauswahl möglich	Nominal	1 = Klinikärzt:in 2 = Hausärzt:in 3 = Fallmanager:innen 4 = Der Einschluss sollte nur nach gemeinsamer Absprache erfolgen 5 = Weitere:	1 = gewählt 0 = nicht gewählt *GKINI_T = Text*
Wie schätzen Sie die Auswirkungen des vorgestellten Versorgungskonzeptes auf die nachfolgenden Aspekte ein?					
ZEIT_GK	Zeitaufwand GK	Zeitaufwand für Ihre Praxis	Ordinal	1 = Geringer 2 = Etwas geringer 3 = Gleich 4 = Etwas höher 5 = Höher	1 = Geringer 2 = Etwas geringer 3 = Gleich 4 = Etwas höher 5 = Höher
BUERO_GK	Bürokratieaufwand GK	Bürokratieaufwand für Ihre Praxis	Ordinal	1 = Geringer 2 = Etwas geringer 3 = Gleich 4 = Etwas höher 5 = Höher	1 = Geringer 2 = Etwas geringer 3 = Gleich 4 = Etwas höher 5 = Höher
BLUT_GK	Verfrühte Entlassung GK	Verfrühte („blutige“) Krankenhausentlassung von Patient:innen	Ordinal	1 = Wird seltener 2 = Wird eher seltener 3 = Bleibt gleich 4 = Wird eher häufiger 5 = Wird häufiger	1 = Wird seltener 2 = Wird eher seltener 3 = Bleibt gleich 4 = Wird eher häufiger 5 = Wird häufiger
REHO_GK	Rehospitalisierung GK	Ungeplante Rehospitalisierung von Patient:innen (Drehtüreffekt)	Ordinal	1 = Wird verhindert 2 = Wird eher verhindert 3 = Bleibt gleich 4 = Wird eher verstärkt 5 = Wird verstärkt	1 = Wird verhindert 2 = Wird eher verhindert 3 = Bleibt gleich 4 = Wird eher verstärkt 5 = Wird verstärkt
GK_NUTZ	Nutzen Konzept	Wie groß schätzen Sie den potenziellen Nutzen des vorgestellten Versorgungskonzepts für Ihre internistischen Patient:innen nach Klinikentlassung ein?	Ordinal	1 = Kein Nutzen 2 = Geringer Nutzen 3 = Mittlerer Nutzen 4 = Großer Nutzen 5 = Weiß nicht	1 = Kein Nutzen 2 = Geringer Nutzen 3 = Mittlerer Nutzen 4 = Großer Nutzen 5 = Weiß nicht

GKPOT GKPOT_T	- Bestandteil Nutzen - Sonstige Potential (T = *FREITEXT für „Etwas anderes, und zwar:“)*	In welchem der vorgestellten Bestandteile sehen Sie das meiste Potenzial zur Verbesserung des Entlassmanagements an der ambulant-stationären Schnittstelle?	Nominal	1 = Sektorenübergreifende Behandlungspläne 2 = Fallmanager:innen 3 = Telemedizinische Betreuung 4 = Das Konzept als Ganzes (sektorenübergreifende Behandlungsplanung, Fallmanager:innen, Smart Devices) 5 = Ich sehe kein Potenzial zur Verbesserung 6 = Etwas anderes, und zwar:	1 = Sektorenübergreifende Behandlungspläne 2 = Fallmanager:innen 3 = Telemedizinische Betreuung 4 = Das Konzept als Ganzes 5 = Ich sehe kein Potenzial zur Verbesserung 6 = Etwas anderes *GKPOT_T = Text*
8. Angaben zu der Praxis, in der Sie tätig sind					
PRXFORM	Praxisform	Bei meiner Praxis handelt es sich um...	Nominal	1 = Eine Einzelpraxis 2 = Eine Praxisgemeinschaft 3 = Eine Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) 4 = Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 5 = Keine Angabe	1 = Eine Einzelpraxis 2 = Eine Praxisgemeinschaft 3 = Eine Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) 4 = Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
PRXREGIO	Praxisregion	In welcher Region befindet sich die Praxis, in der Sie tätig sind?	Ordinal	1 = Landgemeinde (≤ 5000 Einwohner:innen) 2 = Kleinstadt (> 5000-20.000 Einwohner:innen) 3 = Mittelstadt (> 20.000-100.000 Einwohner:innen) 4 = Großstadt (> 100.000 Einwohner:innen)	1 = Landgemeinde (≤ 5000 Einwohner:innen) 2 = Kleinstadt (> 5000-20.000 Einwohner:innen) 3 = Mittelstadt (> 20.000-100.000 Einwohner:innen) 4 = Großstadt (> 100.000 Einwohner:innen)
PRXBULA	Praxis-Bundesland	In welchem Bundesland befindet sich die Praxis, in der Sie tätig sind?	Nominal	1 = Baden-Württemberg 2 = Bayern 3 = Berlin 4 = Brandenburg 5 = Bremen 6 = Hamburg 7 = Hessen 8 = Mecklenburg-Vorpommern 9 = Niedersachsen 10 = Nordrhein-Westfalen 11 = Rheinland-Pfalz 12 = Saarland 13 = Sachsen 14 = Sachsen-Anhalt 15 = Schleswig-Holstein	1 = Baden-Württemberg 2 = Bayern 3 = Berlin 4 = Brandenburg 5 = Bremen 6 = Hamburg 7 = Hessen 8 = Mecklenburg-Vorpommern 9 = Niedersachsen 10 = Nordrhein-Westfalen 11 = Rheinland-Pfalz 12 = Saarland 13 = Sachsen 14 = Sachsen-Anhalt 15 = Schleswig-Holstein

				16 = Thüringen	16 = Thüringen
PRXVZA	Anzahl Ärzt:innen	Wie viele Ärzt:innen arbeiten in Ihrer Praxis (Sie selbst und Weiterbildungsassistent:innen miteingeschlossen)?	Metrisch	Zahl Vollzeitkräfte	*Zahl*
PRXVZNA	Anzahl Personal	Wie viel nicht ärztliches Personal (MFA, Praxismanager:innen) arbeitet in ihrer Praxis?	Metrisch	Zahl Vollzeitkräfte	*Zahl*
9. Angaben zu Ihrem Beruf					
JOBANG	Angestelltenverhältnis	Sind Sie in einem Angestelltenverhältnis tätig?	Nominal	1 = Ja 0 = Nein	1 = Ja 0 = Nein
JOBZEIT	Arbeitszeit	Wie viele Stunden arbeiten Sie durchschnittlich pro Woche?	Metrisch	Zahl h	*Zahl*
JOBFALLZ	Behandlungsfallzahl	Wie hoch ist Ihre persönliche durchschnittliche Behandlungsfallzahl (Scheine) pro Quartal?	Metrisch	Zahl	*Zahl*
JOBPAT1	MM Patient:innen	Wie viel Prozent Ihrer Patient:innen sind älter und multimorbide?	Metrisch	Zahl %	*Zahl*
JOBPAT_2	Drehtür Patient:innen	Wie viele dieser Patient:innen sind „Drehtür-Patient:innen“?	Ordinal	1 = Keine 2 = Wenige 3 = Einige 4 = Viele 5 = Sehr viele	1 = Keine 2 = Wenige 3 = Einige 4 = Viele 5 = Sehr viele
HAUSBPW1	Hausbesuche	Wie viele Hausbesuche führen Sie selbst durchschnittlich pro Woche durch? Wenn Sie keine Hausbesuche durchführen, tragen Sie eine „0“ ein	Metrisch	Zahl	*Zahl*
HAUSBPW2	Hausbesuche Wochenende	Führen Sie selbst für Ihre eigenen Patient:innen im Bedarfsfall Hausbesuche am Wochenende durch?	Nominal	1 = Ja 0 = Nein	1 = Ja 0 = Nein
HAJZA	Berufserfahrung Hausärzt:in	Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Hausärztin/Hausarzt?	Metrisch	Zahl Jahre	*Zahl*
SAJZA	Berufserfahrung stationär	Wie viele Jahre haben Sie bisher im stationären Sektor gearbeitet? Wenn Sie nie stationär tätig waren, tragen Sie eine „0“ ein	Metrisch	Zahl Jahre	*Zahl*
FAWB_1 FAWB_2 FAWB_3 FAWB_4 FAWB_5 FAWB_6 FAWB_T	- In Weiterbildung (1) - Praktische Ärzt:in (2) - Allgemeinmedizin (3) - Innere Medizin (4) - Innere und Allgemeinmedizin (5) - Sonstige FOBI (6) - Sonstige Weiterbildung (T = *FREITEXT für „Sonstige:“*)	Welche fachärztliche Weiterbildung haben Sie? *Mehrfachauswahl möglich*	Nominal	1 = Ärztin/Arzt in Weiterbildung 2 = Praktische Ärztin/ Praktischer Arzt 3 = Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin 4 = Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin 5 = Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin 6 = Sonstige:	1 = gewählt 0 = nicht gewählt *FAWB_T = Text*

10. Ihre Arbeitsbelastung					
JOBBEL	Job-Belastung	Berufliches Burnout bedeutet, sich körperlich, mental und emotional erschöpft zu fühlen. Bitte kreuzen Sie das Streichholz an, welches am besten darstellt, wie ausgebrannt Sie sich derzeit fühlen.	Ordinal	Visuelle Skala 1-8	*Zahl - 1 = geringe Belastung bis 8 = hohe Belastung*
11. Angaben zu Ihrer Person					
PERALT	Alter	Wie alt sind Sie?	Ordinal	1 = 30 Jahre oder jünger 2 = 31 bis 40 Jahre 3 = 41 bis 50 Jahre 4 = 51 bis 60 Jahre 5 = Über 60 Jahre	1 = 30 Jahre oder jünger 2 = 31 bis 40 Jahre 3 = 41 bis 50 Jahre 4 = 51 bis 60 Jahre 5 = Über 60 Jahre
PERGEN	Geschlecht	Mit welchem Geschlecht identifizieren Sie sich?	Nominal	1 = Männlich 2 = Weiblich 3 = Weiteres 4 = keine Angabe	1 = Männlich 2 = Weiblich 3 = Weiteres